

Rodzina jako sojusznik — + *farmakoterapia o ograniczonej roli*

Bliscy potrzebują psychoedukacji, wsparcia, umiejętności reagowania. Leki w AN — ograniczona rola: olanzapina (RFM 0–1 kg), SSRI po refeedingu dla komorbidności.

CZAS: psychoedukacja 2–4 sesje + grupy wsparcia długoterminowe

REALIZACJA: równolegle z każdą terapią AN; farmako — konsultacja psychiatry

ŹRÓDŁO: Treasure, Smith & Crane (2007, *Skills-Based Caring for a Loved One*); Attia & Walsh (2007); Bissada i in. (2008, olanzapina RCT); APA (2023, leki w ED)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery zasady pracy z rodziną** (psychoedukacja, model metafory zwierzęcej (ang. *animal metaphor*), umiejętności reagowania, wsparcie) + **rola leków** w AN. Sekcja 02 — **siedem praktycznych rekomendacji** dla bliskich. Sekcja 03 — **karta rodziny**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rodzina pacjenta z AN jest *kluczowym* kontekstem zdrowienia — niezależnie czy w FBT (Lock & Le Grange, 2013) czy w terapii dorosłych. Treasure, Smith & Crane (2007, *Skills-Based Caring*): bliscy potrzebują psychoedukacji, modelu metafory zwierzęcej (ang. *animal metaphor*) (typy reakcji opiekunów), konkretnych umiejętności rozmowy o jedzeniu, własnego wsparcia. **Farmakoterapia w AN** ma *ograniczoną* rolę. Brak leku „na AN”. Olanzapina (Bissada i in., 2008; APA, 2023): może wspomagać refeeding — średni efekt 0–1 kg dodatkowo, kosztem działań niepożądanych (sedacja, metaboliczne). SSRI po refeedingu — gdy współistnieje depresja lub OCD (przed refeedingiem mało skuteczne — głodzenie blokuje działanie). **Brak farmakoterapii „pierwszej linii”** dla AN — psychoterapia + rehabilitacja żywieniowa zawsze są pierwsze.

01 Cztery zasady pracy z rodziną + rola leków

ELEMENT	KONKRETNA TREŚĆ
1 · Psychoedukacja	AN to choroba, nie wybór. Eksternalizacja: walczymy z AN, nie z dzieckiem. Mit „zaniedbanie rodzicielskie” — nieprawdziwy (genetyka 50–60%). Brak winy.
2 · Metafora zwierzęca (ang. <i>animal metaphor</i> , Treasure)	Typy reakcji opiekunów: <i>kangur</i> (nadopiekuńczy), <i>nosorożec</i> (sztywny, kontrolujący), <i>struś</i> (unikający), <i>meduza</i> (bezsilny), <i>terrier</i> (krytyczny), <i>delfin</i> (elastyczny — cel). Pacjenci najlepiej reagują na delfina.
3 · Konkretnie umiejętności	Jak rozmawiać o jedzeniu, jak nie eskalować konfliktu, jak reagować na opór, jak nie komentować ciała/wagi/wyglądu, jak wspierać autonomię w fazie 2 FBT.
4 · Własne wsparcie opiekunów	Opiekun w stałym kontakcie z AN to wysokie ryzyko wypalenia, depresji, własnego zaburzenia. Grupy wsparcia (np. ED Family Helpline), własna terapia, czas na regenerację.
Farmakoterapia — ograniczona rola	Brak leku „na AN”. Olanzapina (2.5–10 mg): wspomaganie refeedingu, +0–1 kg (Bissada 2008). SSRI: po refeedingu, dla depresji/OCD współistniejących. Przed refeedingiem SSRI mało skuteczne — głodzenie blokuje działanie.

Krytycyzm rodziców = silny predyktor gorszego rokowania. Wysoki EE (*Expressed Emotion*) w rodzinie koreluje z gorszym rezultatem terapii. Praca z krytycyzmem rodziców (psychoedukacja, eksternalizacja AN) to kluczowa część leczenia.

1. **Eksternalizacja AN** — w każdej rozmowie: „to AN każe Ci tak myśleć, nie Ty”. Zmniejsza krytycyzm i opór. Działa w każdym wieku, nie tylko u dzieci.
2. **Nie komentuj ciała/wagi/wyglądu — ani pacjenta, ani innych osób.** Żadnych „świetnie wyglądasz”, „schudłeś/-aś”, „przytyłeś/-aś”. Nawet pozytywne komentarze są ryzykiem (pacjent słyszy „zatem ważne, że jestem szczupła”). Również *nie komentuj wyglądu innych* — to wzmacnia kulturę ciała.
3. **Posiłki: czas wspólny, bez negocjacji co do treści** (w fazie 1 FBT lub równoważnej). Rodzice decydują o porcji, adolescent o szybkości. Bez „zostaw, jeśli nie chcesz” — AN to wykorzystuje.
4. **Reaguj na opór bez eskalacji** — „Wiem, że to trudne. AN każe Ci protestować. Mimo to musimy zjeść — bo zależy mi na Tobie”. Bez krzyku, bez wycofania.
5. **Bez „przekonywania” — to AN-territory** — argumenty „schudłeś/-aś, jest źle” wzmacniają opór (reactance). Zamiast: walidacja emocji + jasne stanowisko o jedzeniu („rozumiem, że boisz się, że przytyjesz. Mimo to musimy zjeść kolację”).
6. **Wspólne aktywności poza jedzeniem** — wspólne hobby, wyjścia, rozmowy *niezwiązane* z AN. Pacjent musi pamiętać, że jest *kimś poza pacjentem*. Relacja nie może się sprowadzać do walki o jedzenie.
7. **Zadbaj o siebie** — wypalenie opiekuna to wysokie ryzyko. Grupy wsparcia, własna terapia, regularny odpoczynek, czas dla innych członków rodziny, czas dla siebie. „Nie można pomóc tonącemu, jeśli sam się topisz”.

MÓJ DOMINUJĄCY STYL REAKCJI NA AN BLISKIEJ OSOBY

— kangur, nosorożec, struś, meduza, terrier, delfin (Treasure 2007)

JAKIE SYTUACJE SĄ DLA MNIE NAJTRUDNIEJSZE

— posiłki, opór, krzyk, milczenie, „tracenie” bliskiej osoby na rzecz AN

CZEGO POTRZEBUJĘ JAKO OPIEKUN

— informacji, grupy wsparcia, własnej terapii, czasu dla siebie, koordynacji z zespołem leczącym

PYTANIA DO ZESPOŁU LECZĄCEGO O LEKACH

— rola olanzapiny, SSRI, kiedy włączać, kiedy odstawić, działania niepożądane

Klucz: rodzina jest *sojusznikiem* w leczeniu AN — niezależnie czy w FBT (formalnie zaangażowana) czy w terapii dorosłych (jako system wsparcia). Bez psychoedukacji rodziny — krytycyzm, niewłaściwe reakcje, własne wypalenie obniżają skuteczność terapii. **Farmakoterapia:** *nie* jest pierwszą linią leczenia AN. Olanzapina może wspomóc refeeding (efekt mały, 0–1 kg). SSRI dla komorbidności *po* refeedingu. Wszystko zawsze w połączeniu z psychoterapią i rehabilitacją żywieniową. **Komunikat dla rodziny:** „Wasze zaangażowanie ma znaczenie. Nie sami z tym zostajecie — jesteśmy w zespole. Macie prawo do własnego wsparcia, do pytań, do trudnych emocji”.

⚠ **Olanzapina — uwaga:** stosowanie off-label w AN. Wymaga zgody pacjenta i opiekunów, monitorowania metabolicznego (waga, lipidogram, glukoza, EKG), oceny stosunku korzyść/ryzyko. Nie powinna zastępować rehabilitacji żywieniowej. SSRI: *nie* stosować jako monoterapię AN — brak skuteczności. SSRI dla współistniejącej depresji/OCD po osiągnięciu BMI >17–18.